

NS 22231696570/765

LOURDES Montini Binde

IDADE: 48 PESO: 91 ALTURA: 1,75 PROFISSÃO: Adm. Empresas

SINTOMAS: Sonolência Ronco / Fala dormindo / MMEI ede

QUEIXAS: Refluxo gástrico /

MEDICAMENTOS: Prolopa 4x/dia / Duoro / Omezartana /
Labin / Vernifit / ResidrosMÉDICO: Dr^a Ludmilla / Dr^o Louro

EXERCÍCIO FÍSICO: Pilates 2x / fisiot. cardiop.

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: 18hs

HORA QUE DORME: 22:30 HORA QUE ACORDA: 5hs

COCHILHO () SIM () NÃO ^{7-9h} 40! DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUALBEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA ~~X~~ NÃOFUMO () SIM () MAÇO/DIA ~~X~~ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:TIPO DE RESPIRAÇÃO: Rala ~~Boca~~ BANHEIRO: 3 a 4X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP:

MALLAMPATI:

IAH: 65,6/h SPO2: 77%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA

() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS

14/06 - Início tratamento
MSG p/ filha05/07 P = 9.5 cmH₂O

23 IAH = 6.3 e/h

M. de uso: 6:32'

De dia colocar o CPAP.

fua.

06/09/23 P = 9.6 cmH₂O

usou pouco dias /

IAH = 6.2 e/h

fuga = 21.4 l/min

ajuste másc / como neuropat

27/09 P = 9.6 cmH₂O

ajuste a másc.

23

IAH = 2.6

M. de uso: 4h8'

e fapco relatório

fua.

24/06

P = 9.6 cmH₂O

IAH = 19.2

24

M. de uso: 6h23

fuga = 25.3 l/min

fua.

27M P: 9,0 cm H₂O
24 IAH = 25,1 a/h
m de m: 52,18
fuga: 11,8 l/m

agosto P: 9,9 cm H₂O
Natacha

Formulário de avaliação médica com campos para:

- QUEIXAS
- SINTOMAS
- MEDICAMENTOS
- MEDICO
- EXERCÍCIO FÍSICO
- HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ
- ALMOÇO
- JANTAR
- HORA QUE DORME
- COCHILHO
- BEBIDA ALCOÓLICA
- FUMO
- TIPO DE RESPIRAÇÃO
- CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL
- OVERLAP
- PATOLOGIAS ASSOCIADAS
- CIRURGIAS
- HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE
- COMORBIDADES
- (ORTOPÉDICA)
- (NEUROLÓGICA)
- (OUTROS)
- (ENDOCRINA)
- (CARDIACA)

Handwritten notes and calculations at the bottom of the page, including:

- 02/04 P: 9,2 cm H₂O
- 05 IAH = 25,1 a/h
- M. de m: 52,18
- fuga: 11,8 l/m

Nome: LOURDES MONTINI BINOTO

Peso: 99 kg

Data de Nascimento: 1-9-1944

Altura: 1,75 m

IMC: 32,33

Médico: DRA. LUDMILLA M. COPPIO

Sexo: Feminino

Medicamentos:

Data do exame: 06-05-2023

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 06-05-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 478,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 5,5 e 110,5 minutos. O tempo total de sono foi de 408,0 min, eficiência de 85,4% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,5%; estágio N2: 73,3%; estágio N3: 4,4%; sono REM: 19,9%. O índice de despertares foi de 43,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 65,6/hora, sendo 16 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 393 hipopnéias. A SpO2 média foi de 90% e a mínima de 77%, permanecendo 21,8% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 49 - 74 bpm e NREM de 51 - 76 bpm.

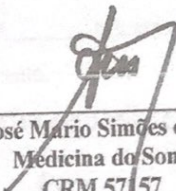
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (16), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 65,6/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=77%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157